

Seminar HfWU Theatertherapie

Evidenz in der Theatertherapie

Tag 1



Institut für Forschung und Entwicklung
in den Künstlerischen Therapien

ERINN WEBB
Miss Kendra Programs

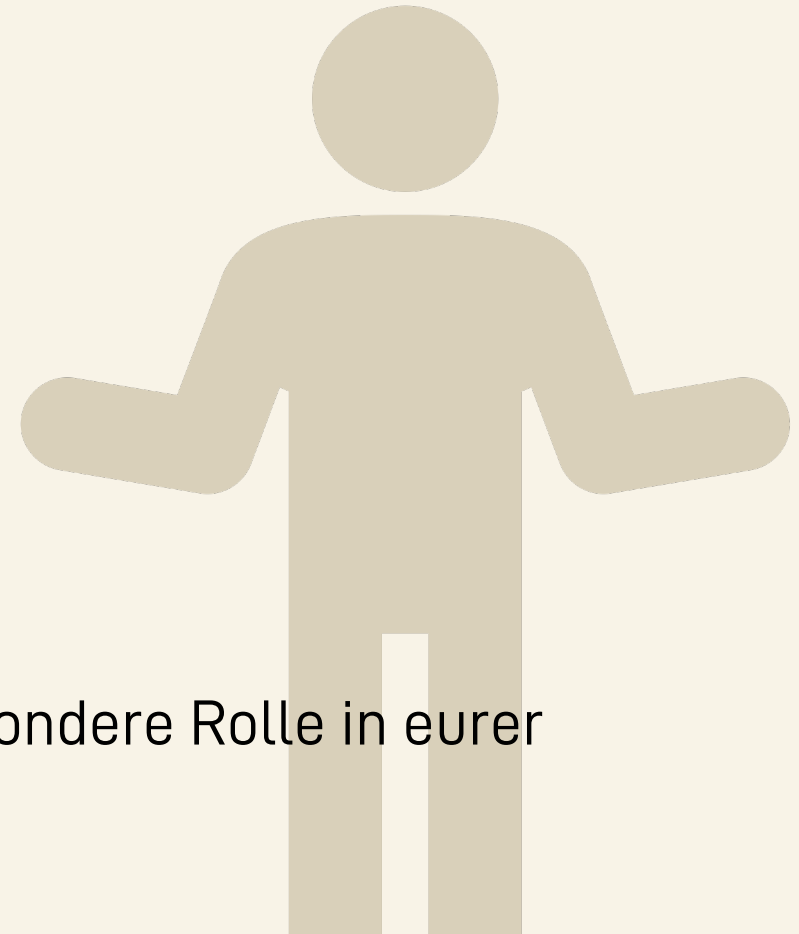
Pocket play: Playful persona as an approach to stress- reduction in an elementary school program

ABSTRACT

Past experiences of trauma can impede children's learning and success. Playful interactions between skilled counsellors and students can help mitigate the impact of trauma. The author presents a case example of brief drama in a school program.

KEYWORDS

socio-emotional
trauma-informed
st



Habt ihr **Artikel oder Bücher** die für euch eine besondere Rolle in eurer theatertherapeutischen Entwicklung hatten?

Agenda

Tag 1

- Evidenz-basierte Medizin und Theatertherapie
- Wie wollen wir Forschung in der Theatertherapie gestalten?
- Prozessforschung in den Künstlerischen Therapien

Tag 2

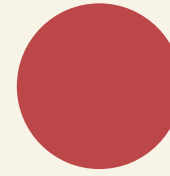
- Was ist qualitative Forschung in der Theatertherapie?
- Theorie in qualitativer Forschung
- Deskriptiv-interpretative Analyse

What is evidence-based medicine?

Evidence-based medicine (EBM) requires the integration of the best research evidence with our clinical expertise and our patient's unique values and circumstances.

- By *best research evidence*, we mean clinically relevant research, sometimes from the basic sciences of medicine, but especially from patient-centred clinical research into the accuracy and precision of diagnostic tests (including the clinical examination), the power of prognostic markers, and the efficacy and safety of therapeutic, rehabilitative, and preventive strategies.
- By *clinical expertise*, we mean the ability to use our clinical skills and past experience to rapidly identify each patient's unique health state and diagnosis, his or her individual risks and benefits of potential interventions/exposures/diagnostic tests, and his or her personal values and expectations. Moreover, clinical expertise is required to integrate evidence with patient values and circumstances.
- By *patient values*, we mean the unique preferences, concerns, and expectations that each patient brings to a clinical encounter and that must be integrated into shared clinical decisions if they are to serve the patient; by *patient circumstances*, we mean the patient's individual clinical state and the clinical setting.

Why the interest in EBM?



Was ist **evidence-based medicine**?



What is evidence-based medicine?

Evidence-based medicine (EBM) requires the integration of the best research evidence with our clinical expertise and our patient's unique values and circumstances.

- By *best research evidence*, we mean clinically relevant research, sometimes from the basic sciences of medicine, but especially from patient-centred clinical research into the accuracy and precision of diagnostic tests (including the clinical examination), the power of prognostic markers, and the efficacy and safety of therapeutic, rehabilitative, and preventive strategies.
- By *clinical expertise*, we mean the ability to use our clinical skills and past experience to rapidly identify each patient's unique health state and diagnosis, his or her individual risks and benefits of potential interventions/exposures/diagnostic tests, and his or her personal values and expectations. Moreover, clinical expertise is required to integrate evidence with patient values and circumstances.
- By *patient values*, we mean the unique preferences, concerns, and expectations that each patient brings to a clinical encounter and that must be integrated into shared clinical decisions if they are to serve the patient; by *patient circumstances*, we mean the patient's individual clinical state and the clinical setting.

Why the interest in EBM?

1

Research Evidence

2

Clinical Expertise

3

Client's Values and Circumstances

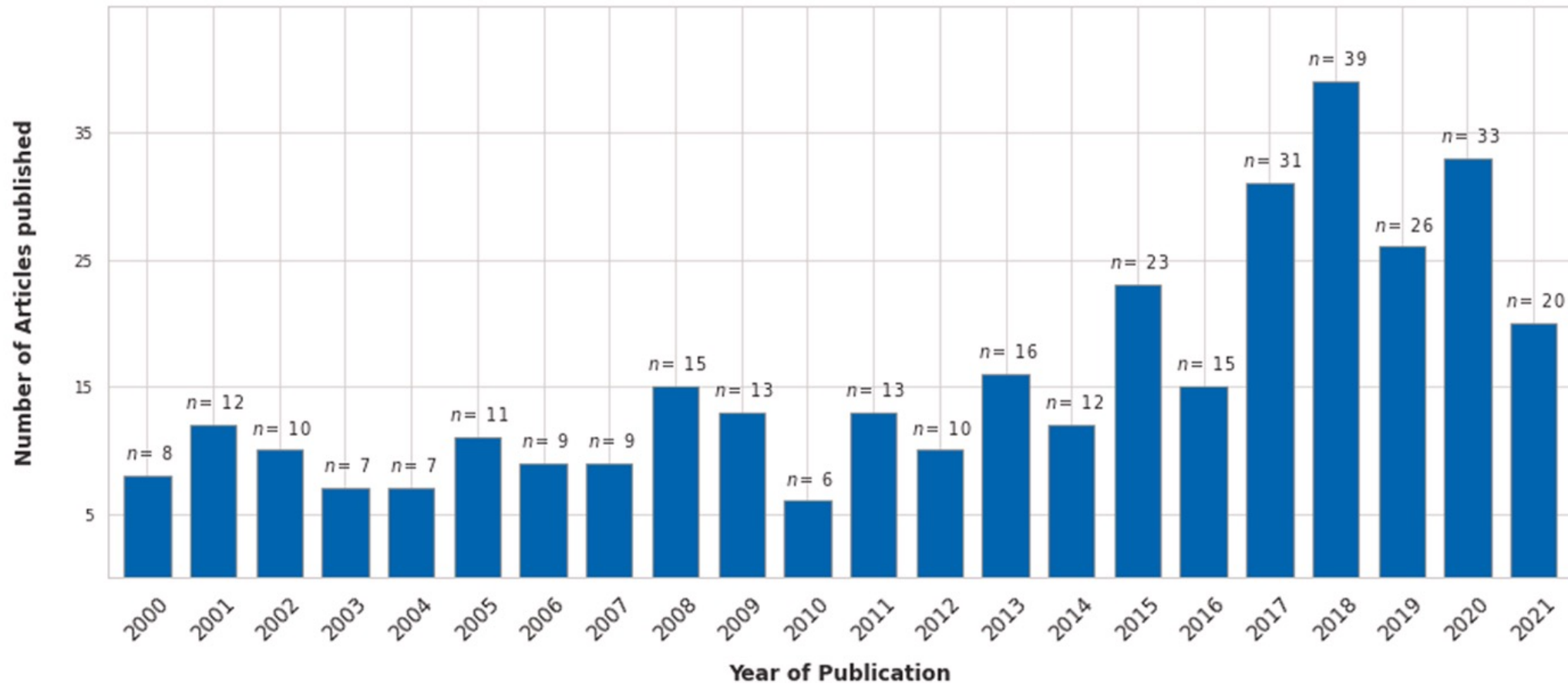


Fig. 2. The number of published articles per year. Note. $N = 345$.

There has been a steady increase in publications in the field of dramatherapy over the last twenty years.

Table 1*Main Characteristics of Included Studies*

Authors	Date	PD/ DT	n (total)	Study quality	Study design	Type of outcome/s	Age group	Setting	Country
Carbonell and Partelano-Barehmi	1999	PD	26	Moderate	RCT	Illness-reduction	Youth	School	USA
Costa et al.	2006	PD	20	Weak	CCT	Illness-reduction and Health-promotion	Adults	Other	Brazil
Dehnavi et al.	2016	PD	30	Moderate	RCT	Health-promotion	Adults	Medical	Iran
Dehnavi et al.	2019	PD	20	Weak	RCT	Health-promotion	Adults	Community	Iran
Dogan	2010	PD	20	Strong	RCT	Illness-reduction	Adults	Other	Turkey
Gulassa et al.	2019	PD	19	Moderate	CCT	Illness-reduction and Health-promotion	Adults	Medical	Brazil
Jaaniste et al.	2015	DT	13	Weak	CCT	Health-promotion	Older adults	Community	Australia
Kähönen et al.	2012	PD	77	Strong	RCT	Health-promotion	Adults	Medical	Scandinavia
Karatas and Gökçakan	2009b	PD	23	Strong	RCT	Illness-reduction	Youth	School	Turkey
Karatas and Gökçakan	2009a	PD	24	Moderate	RCT	Illness-reduction	Youth	School	Turkey
Kaya and Deniz	2020	PD	27	Weak	RCT	Health-promotion	Adults	Other	Turkey
Keisari and Palgi	2017	DT	55	Moderate	CCT	Illness-reduction and Health-promotion	Older adults	Community	Israel
Keisari et al.	2022	DT	78	Strong	RCT	Illness-reduction and Health-promotion	Older adults	Community	Israel
Kipper and Giladi	1978	PD	36	Strong	RCT	Illness-reduction	Adults	Other	Israel
McArdle et al.	2002	DT	97	Strong	RCT	Illness-reduction	Children	School	UK
Mechaeli et al.	2009	DT	8	Weak	RCT	Health-promotion	Older adults	Community	England
Moula et al.	2020	DT	44	Weak	RCT	Health-promotion	Children	School	Spain
Oguzhanoglu et al.	2013	PD	28	Moderate	CCT	Illness-reduction	Adults	Medical	Turkey
Orkibi, Azoulay, Snir et al.	2017	PD	40	Moderate	CCT	Illness-reduction and Health-promotion	Youth	School	Israel
Özbaş and Tel	2016	PD	82	Moderate	RCT	Illness-reduction and Health-promotion	Adults	Medical	Turkey
Rezaeian et al.	1997	PD	54	Strong	CCT	Illness-reduction and Health-promotion	Not reported	Psychiatric	Iran
Rousseau et al.	2007	DT	123	Weak	CCT	Health-promotion	Youth	School	Canada
Simsek et al.	2021	PD	22	Weak	CCT	Health-promotion	Adults	Medical	Turkey
Slawson	1965	PD	54	Strong	RCT	Illness-reduction	Adults	Psychiatric	USA
Smokowski and Bacallao	2009	PD	81	Moderate	RCT	Illness-reduction	Youth	Community	USA
Sproesser et al.	2010	PD	16	Weak	RCT	Illness-reduction	Older adults	Medical	Brazil
Tarashoeva et al.	2017	PD	40	Moderate	RCT	Illness-reduction and Health-promotion	Adults	Psychiatric	Bulgaria
Tschuschke and Anbeh	2000	PD	297	Strong	CCT	Illness-reduction and Health-promotion	Adults	Psychiatric	Germany
Uğurlu et al.	2020	PD	12	Weak	CCT	Health-promotion	Adults	Psychiatric	Germany

Quantitative Meta-Analysis

Orkibi et al. (2023)



7 Theatertherapie-Studien



418 Studienteilnehmende

 $d = .55, 95\% \text{ CI } [.11, .99], p < .001$

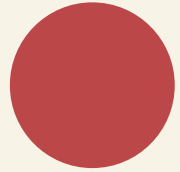
Figure 2
Client's Experiences of Drama Therapy



Qualitative Meta-Analyse

Constien et al. (2024)

- 20 Theatertherapie-Studien
- 302 Studienteilnehmende
- Klienten haben überwiegend positive Erfahrungen in der Theatertherapie

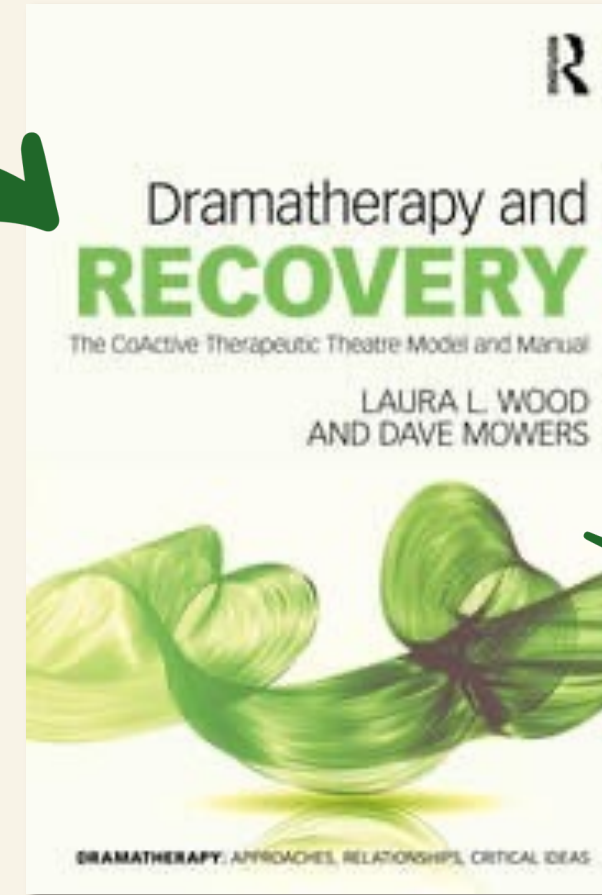
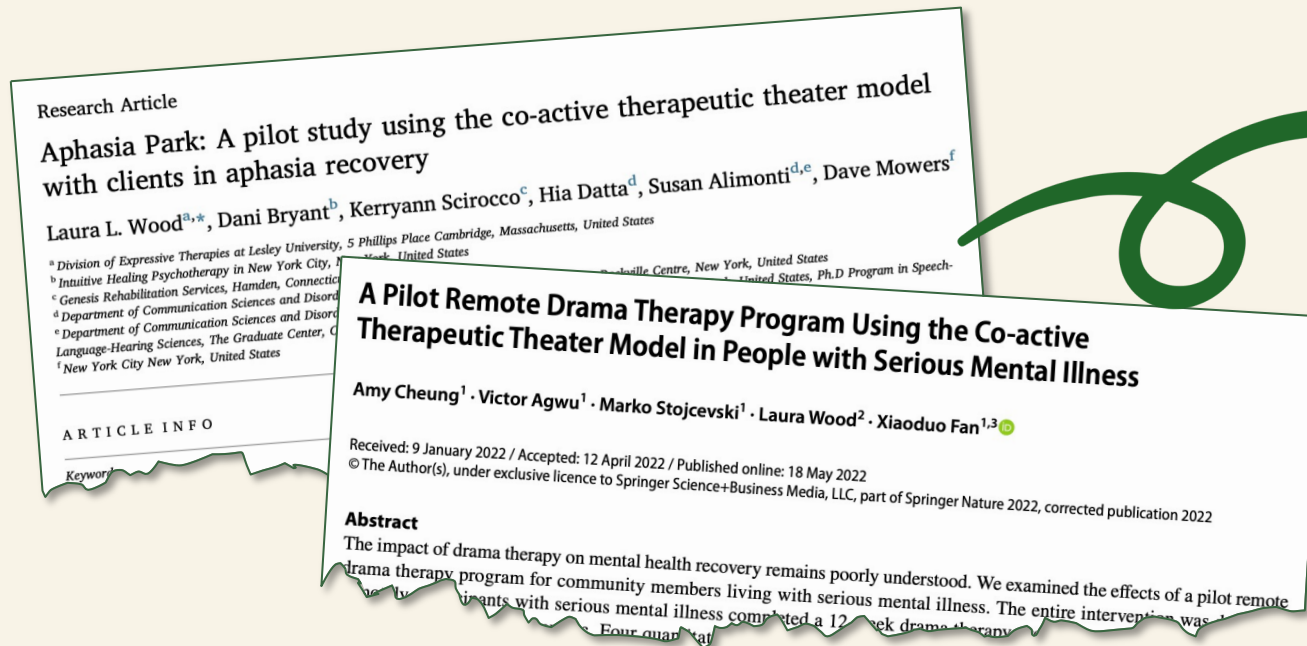


Reicht unsere aktuelle Evidenzbasis aus, um Theatertherapie als **evidenzbasierte Therapieform** zu empfehlen?



Probleme in der theatertherapeutischen Forschung

Eine Auswahl



Wood et al., 2020

Cheung et al., 2022

Wood & Mowers, 2024

Probleme in der theatertherapeutischen Forschung

Eine Auswahl

Sensory sensitivity and reconnection

At the start of the drama therapy session, Neomi is in the empty drama therapy room with a big woollen carpet, some cushions and a witnessing circle, unable to meet the gaze of the drama therapist and make eye contact. She stares to the ground or the door. Her body seems physically restricted and her facial muscles are tense. Neomi holds her breath. When the drama therapist asks about her feelings, she speaks haltingly, as if having difficulty finding words to describe what she is feeling. Although Neomi hardly makes eye contact, her eyes seem to follow accurately every move the drama therapist makes. Neomi looks alert. Alone in a room with a male drama therapist, probably near the age of her father, must be terrifying for her. When the drama therapist checks his assumption, she expresses that she can imagine that it might be true. It surprises the drama therapist when she positions herself on the carpet opposite the therapist and pleasantly inquires about what she should do. She appears ready to be invited for play and focused on detecting what is expected from her. The drama therapist expresses his surprise and at the same time he imagines how it would be very possible to pursue a playful interaction, believing that it would be reciprocal and how it probably would re-enact for Neomi familiar abusive relational patterns. The drama therapist feels trapped. When he tries to escape by offering Neomi different options she is confused and does not know what to choose. The drama therapist is aware

To encour
den

Williamsen, 2020

at any given moment. The dramatherapists remained 'attuned' to the needs of the clients. For example, while facilitating a group, [Hubbard \(2008\)](#) commented that:

"...in one session that there was a lot of physical pain in the group at the moment and wondered with them if it would be helpful to externalise this in some way. They decided to draw an image of a body and show on this where their different problems were. The character was given back, neck, knee, foot and stomach pain and migraines. Some of the representation was of emotional pain too. It was given tears. The process proved very cathartic. They imagined the image as a real person and invited her/him to be a group member for that session, giving it a chair of its own. They then expressed sympathy for this new person with all its problems and pain." ([Hubbard, 2008](#), p. 10)

Hubbard was responding to what she saw in the room. In doing so she allowed the clients to engage with their difficulty and acknowledge it in some way.

Cassidy et al., 2014

Probleme in der theatertherapeutischen Forschung

Eine Auswahl

Welches Format?
Welche Zielgruppe?
Welche Materialien?

Sensory sensitivity and reconnection

At the start of the drama therapy session, Neomi is in the empty drama therapy room with a big woollen carpet, some cushions and a witnessing circle, unable to meet the gaze of the drama therapist and make eye contact. She stares to the ground or the door. Her body seems physically restricted and her facial muscles are tense. Neomi holds her breath. When the drama therapist asks about her feelings, she speaks haltingly, as if having difficulty finding words to describe what she is feeling. Although Neomi hardly makes eye contact, her eyes seem to follow accurately every move the drama therapist makes. Neomi looks alert. Alone in a room with a male drama therapist, probably near the age of her father, must be terrifying for her. When the drama therapist checks his assumption, she expresses that she can imagine that it might be true. It surprises the drama therapist when she picks up a cushion on the carpet opposite the therapist and pleasantly inquires about what she should do. She appears ready to be invited for play and focused on detecting what is expected from her. The drama therapist expresses his surprise and at the same time he imagines how it would be very possible to pursue a playful interaction, believing that it would be reciprocal and how it probably would re-enact for Neomi familiar abusive relational patterns. The drama therapist feels trapped. When he tries to escape by offering Neomi different options she is confused and does not know what to choose. The drama therapist is aware that in this phase there might be a need for a more structured approach.

To encourage
Neomi to
express her
feelings

Williamsen, 2020

at any given moment. The dramatherapists remained 'attuned' to the needs of the clients. For example, while facilitating a group, [Hubbard \(2008\)](#) commented that:

"...in one session that there was a lot of physical pain in the group at the moment and wondered with them if it would be helpful to externalise this in some way. They decided to draw an image of a body and show on this where their different problems were. The character was given back, neck, knee, foot and stomach pain and migraines. Some of the representation was of emotional pain too. It was given tears. The process proved very helpful. They imagined the image as a real person and invited her/him to be a group member for that session, giving it a chair of its own. They then expressed sympathy for this new person with all its problems and pain." ([Hubbard, 2008](#), p. 10)

Hubbard was responding to what she saw in the room. In doing so she allowed the clients to engage with their own experiences and acknowledge their own feelings.

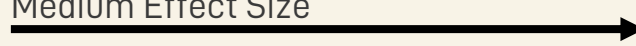
Cassidy et al., 2014

Probleme in der theatertherapeutischen Forschung

Eine Auswahl

Creative Arts Therapies

Medium Effect Size



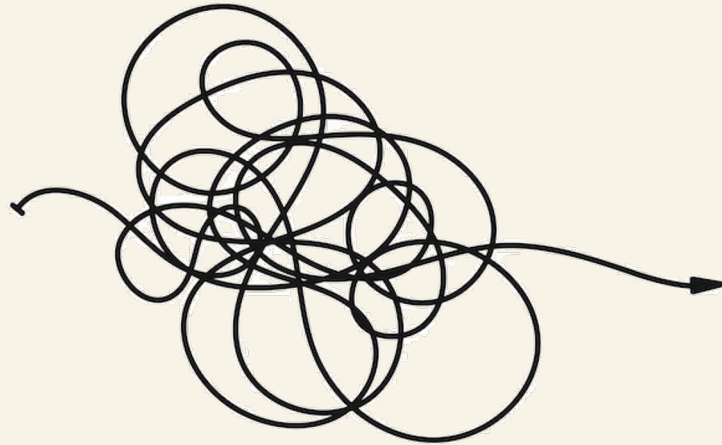
Mental Health Outcomes

de Witte et al., 2022; Jiang et al., 2020; Koch et al., 2020; Newland & Bettencourt, 2020; Orkibi et al., 2023; Tang et al., 2020

Probleme in der theatertherapeutischen Forschung

Eine Auswahl

Creative Arts Therapies



Mental Health Outcomes

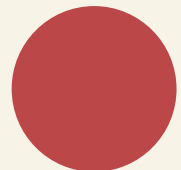
Probleme in der theatertherapeutischen Forschung

Eine Auswahl

 **Closed Circles und Research Silos**

 **Was ist Theatertherapie?**

 **Wie funktioniert Theatertherapie?**

 Welche **Probleme** seht ihr sonst noch?





Lesegruppe I

A



Laura Wood, 2021

Empirical Research Consideration in Drama Therapy

B



Angelle Cook et al., 2025

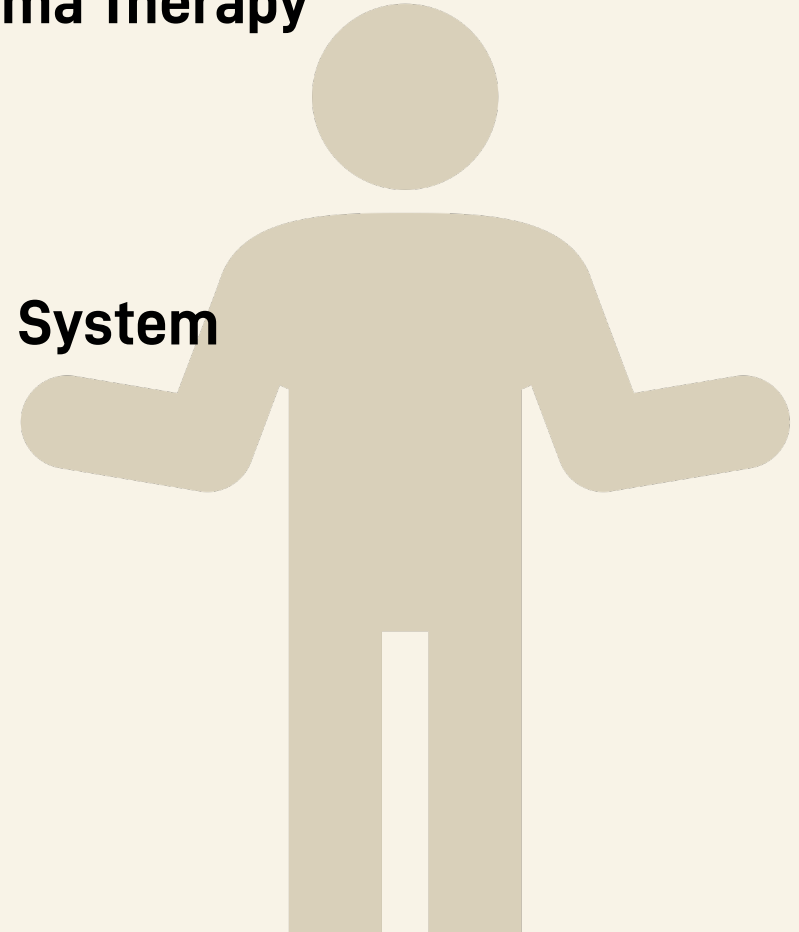
The Drama Therapy Core Process Coding System

C



Constien., 2024

Open Dramatherapy



Was geht hier denn ab?!

Prozessforschung
in der Psychotherapie

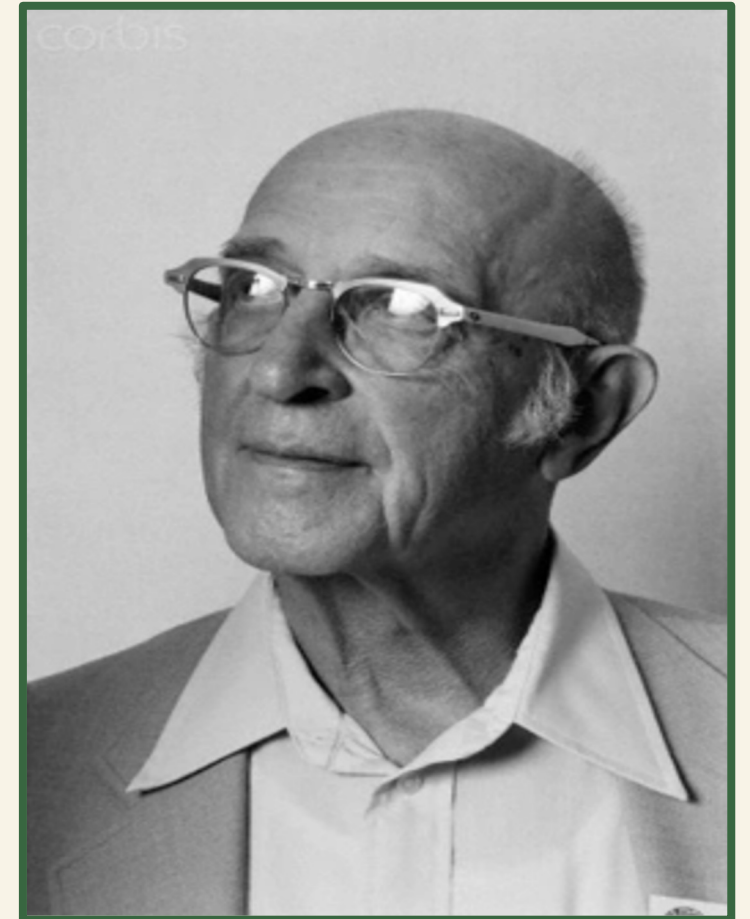
Prozessforschung in der Psychotherapie

- Forschungsansatz zur Untersuchung dessen, **was im therapeutischen Prozess** geschieht
- Fokus auf **Veränderungs- oder Wirkmechanismen** statt nur auf Outcomes/Ergebnisse

Future Directions for CAT Research

Whereas psychotherapy outcome research inquires whether or not treatment leads to change, change process research inquires *how* or *why* psychotherapy leads to change (Kazdin, 2009). Given the growing interest in psychotherapy research beyond outcome studies, it is important to identify CAT factors that lead to the *change process*.

Orkibi & Keisari, 2023



Carl Rogers (1902–1987)

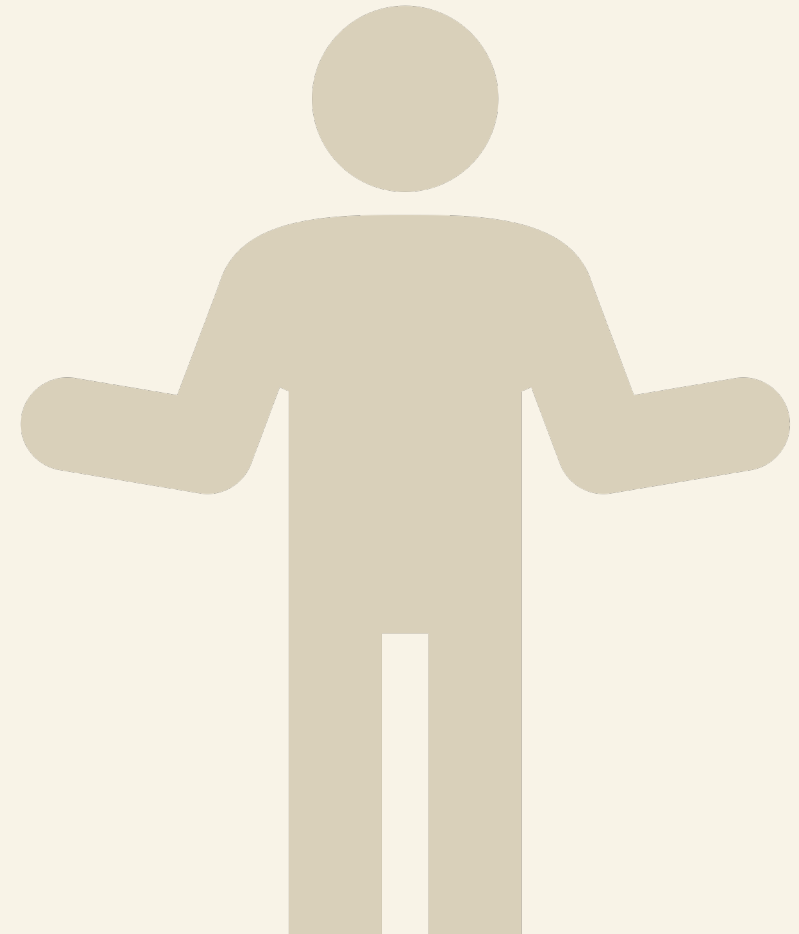
Prozessforschung in der Psychotherapie

Therapeutische Beziehung

- Starker Zusammenhang mit Therapieerfolg
- Allianz als dynamischer, veränderlicher Prozess
- Reparatur von Brüchen als Wirkfaktor



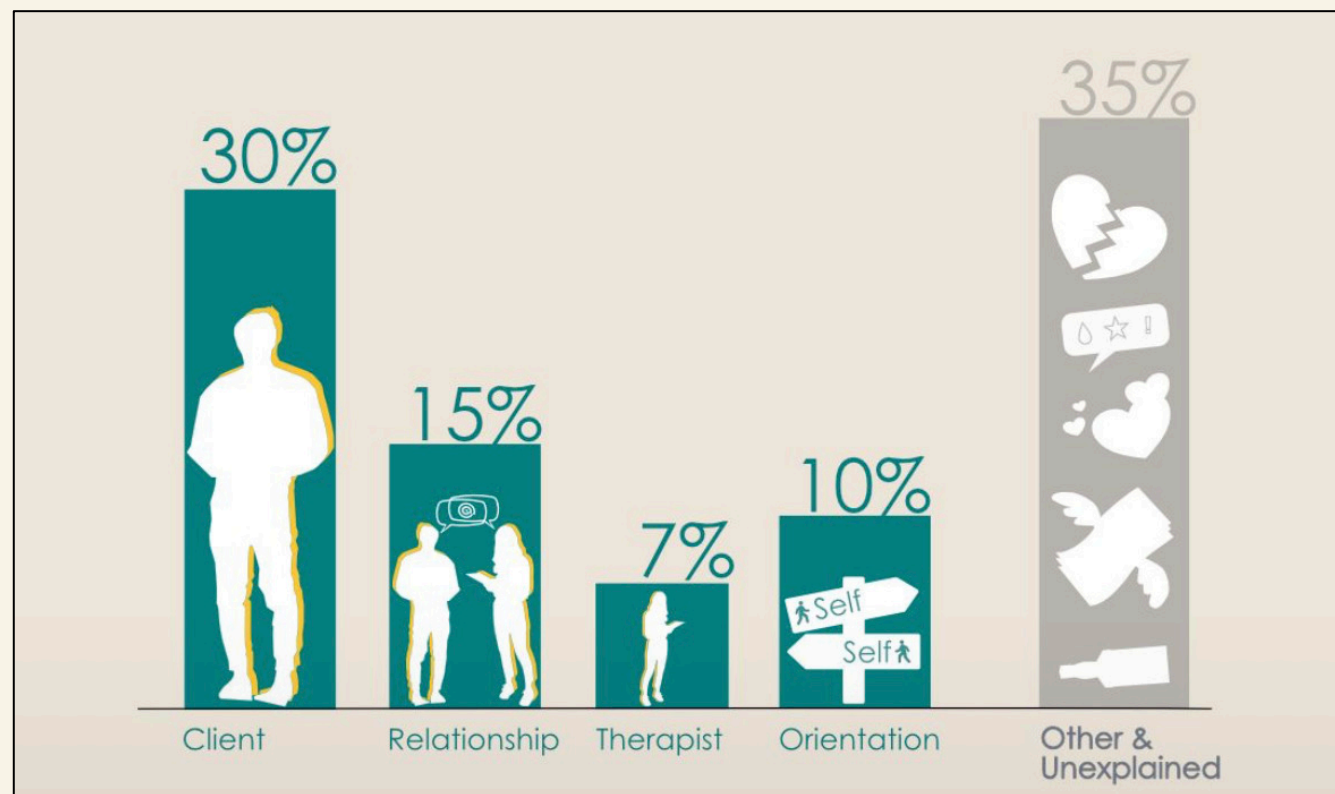
Wer bestimmt die therapeutische Beziehung?



Prozessforschung in der Psychotherapie

*"My position is not that technique is irrelevant to outcome. Rather, I maintain that... the **success of all techniques depends on the patient's sense of alliance with an actual or symbolic healer.** This position implies that ideally therapists should select for each patient the therapy that accords, or can be brought to accord, with the patient's personal characteristics and view of the problem."*

Frank & Frank, 1991, p. XV



Adapted from Norcross & Lambert (2019)



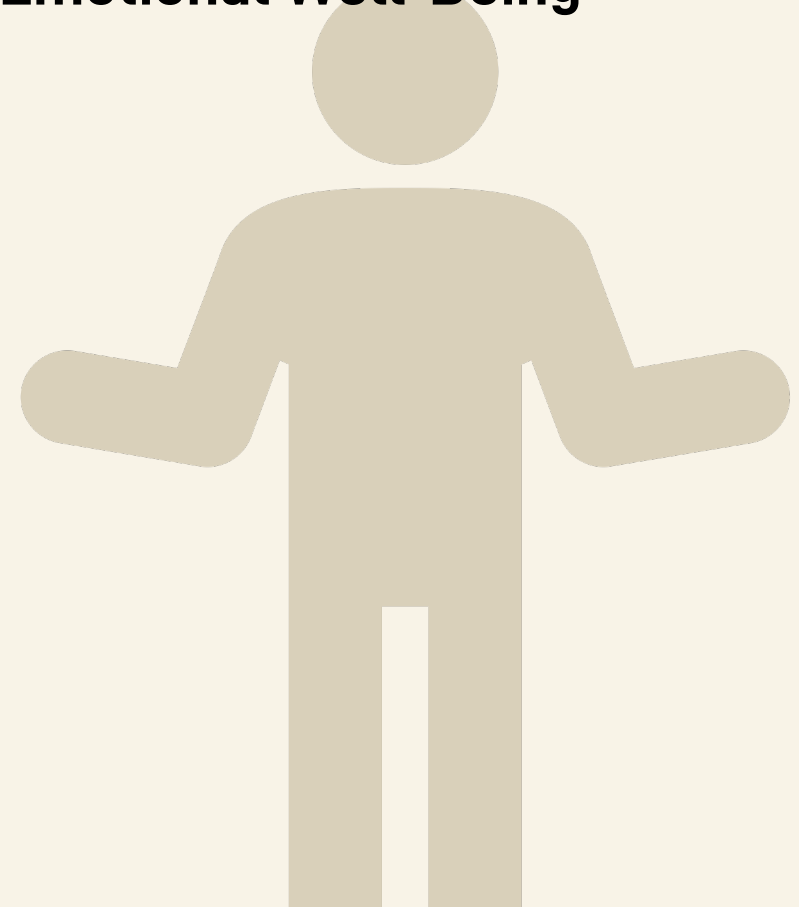
Lesegruppe II

A



Shoshi Keisari & Hod Orkibi, 2021

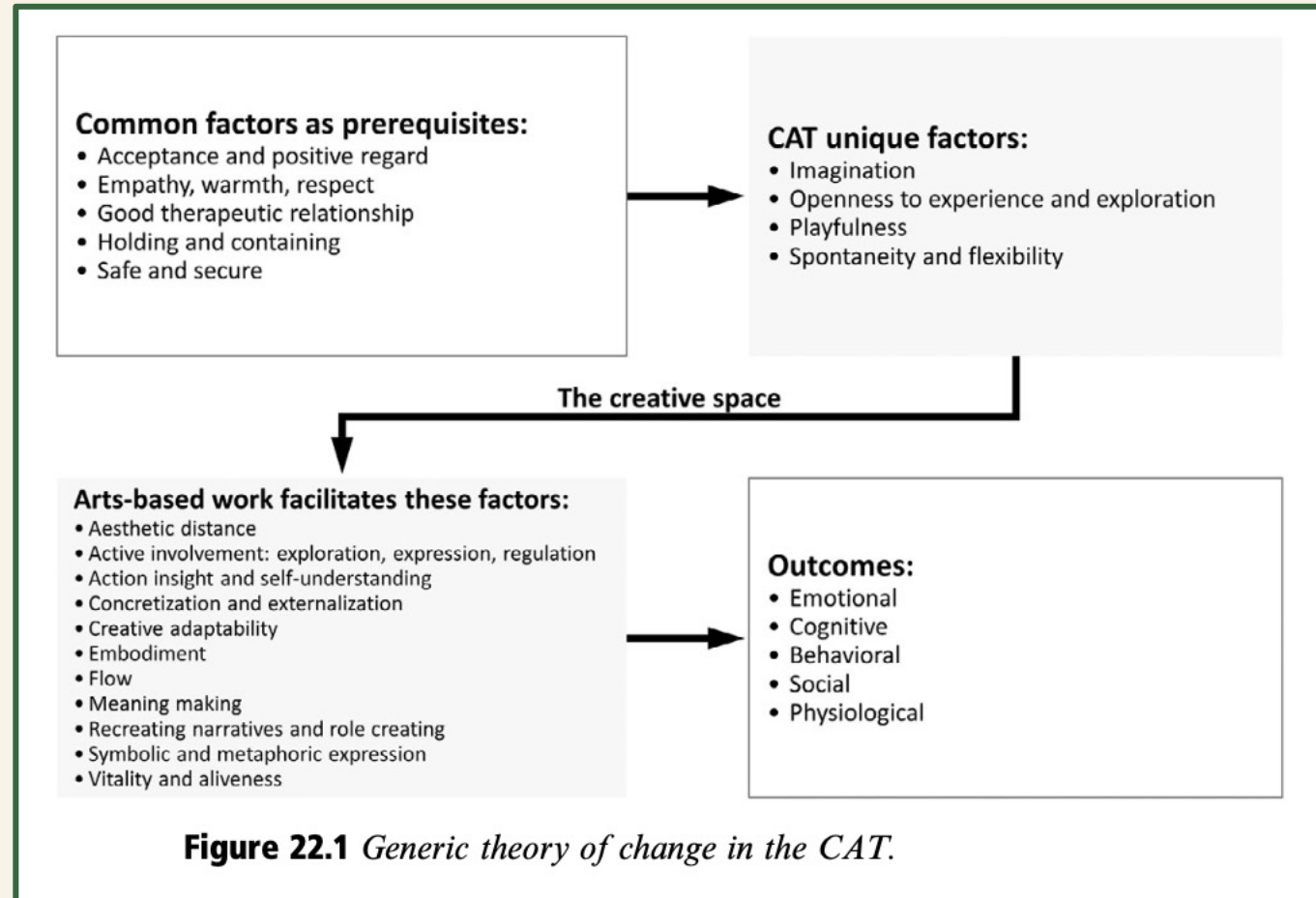
Processes and Outcomes for Emotional Well-Being





Shoshi Keisari & Hod Orkibi, 2021

Processes and Outcomes for Emotional Well-Being



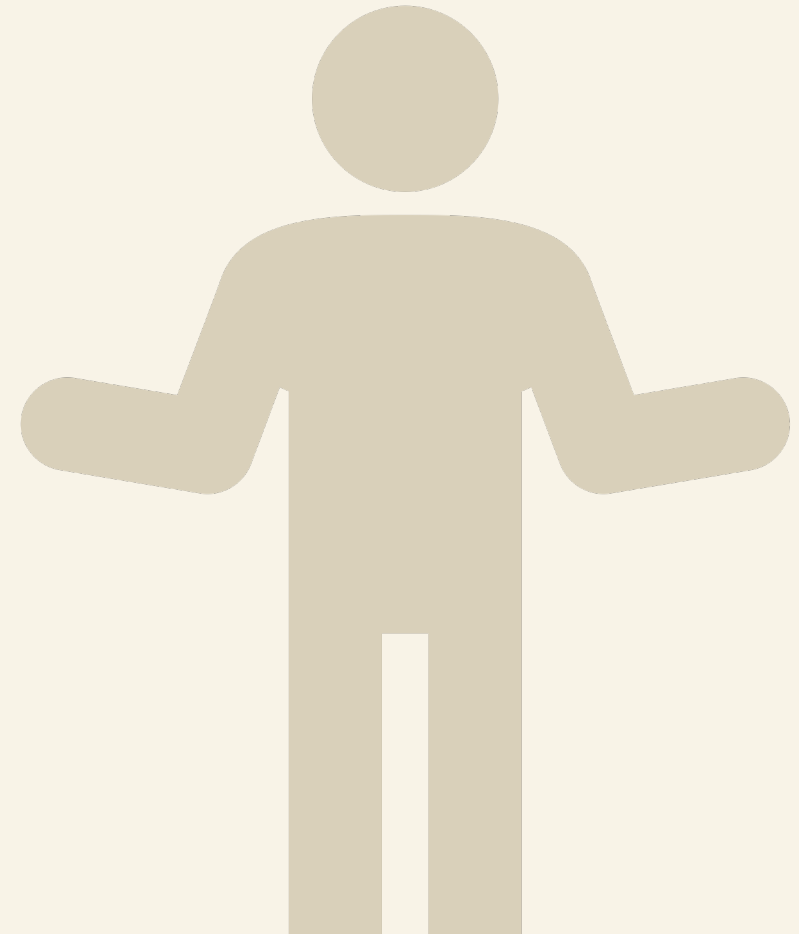
Prozessforschung in der Psychotherapie

Typische Fragestellungen

- Welche Interventionen sind in welchem Moment hilfreich?
- Wie entsteht ein therapeutischer Wendepunkt?
- Welche Rolle spielen Beziehung und Allianz?
- Wie erleben Klient:innen Veränderung subjektiv?



Wie kann man solche Fragen beantworten?





Lesegruppe III

- A**  **Quantitative Process-Outcome Design**
- B**  **Qualitative Helpful Factors Design**
- C**  **Microanalytic Sequential Process Design**
- D**  **Significant Events Approach**

Quantitative Process-Outcome Design

- Verknüpft therapeutische **Prozesse mit Therapieerfolg.**
- Sehr verbreitet und gut etabliert.
- Fokus vor allem auf therapeutische Beziehung.
- Prozesse werden **beobachtet** oder gezielt **verändert**.

Stärken

- Intuitiv, leicht verständlich
- Hohe Akzeptanz in Forschung und Praxis
- Wichtig zur Erforschung von Wirkmechanismen

Schwächen

- Vereinfacht den Prozess auf wenig messbare Variablen.
- Messprobleme in Prozess und Therapieerfolg.
- Correlation doesn't imply causation.

Qualitative Helpful Factors Design

- Fragt Klient:innen, was in der Therapie hilfreich (oder unhilfreich) war
- Datenerhebung: qualitative Interviews oder kurze Post-Session-Fragebögen
- Liefert dichte Beschreibungen von Veränderungsprozessen
- Weit verbreitet in qualitativer Einzelfall- und Prozessforschung

Stärken

- Klient:innenperspektive („Ask the client“)
- Praxisnah und gut integrierbar in größere Studien
- Qualitative Methoden zunehmend etabliert

Schwächen

- Subjektive Zuschreibungen können fehlerhaft sein
- Begrenzte sprachliche Zugänglichkeit von Veränderungsprozessen
- Teilweise geringe Akzeptanz bei stark quantitativen Ansätzen

Microanalytic Sequential Process Design

- Untersucht turn-by-turn-Interaktionen zwischen Klient:in und Therapeut:in
- Fokus auf unmittelbare Wirkungen therapeutischer Interventionen
- Quantitative Kodierung weniger Prozessvariablen
- Testet theoretische Annahmen zu Wirkmechanismen in Sitzungen

Stärken

- Sehr nahe am konkreten therapeutischen Geschehen
- Ermöglicht Aussagen über kausale Einflussprozesse
- Potenziell praxisrelevant

Schwächen

- Aufwendig und methodisch komplex
- Schwache Verbindung zu Therapieergebnissen
- Selten genutzt, v. a. gegenüber Outcome- und RCT-Forschung

Significant Events Research

- Kombiniert qualitative & quantitative Ansätze
- Fokus auf bedeutsame Momente in der Therapie
- Untersucht hilfreiche und hinderliche Ereignisse
- Zentrale Formen: Task Analysis, Comprehensive Process Analysis

Stärken

- Sehr praxisnah und klinisch anschaulich
- Gut geeignet für Theorieaufbau und Fallstudien
- Verknüpft Prozess, Sequenz und Outcome

Schwächen

- Methodisch anspruchsvoll und zeitintensiv
- Oft kleine Stichproben / Einzelfälle
- Bisher wenig verbreitet

Seminar HfWU Theatertherapie

Evidenz in der Theatertherapie

Tag 2



Institut für Forschung und Entwicklung
in den Künstlerischen Therapien



Erwartungschecking

- **Was erwartet ihr von dem heutigen Tag?**
- **Was werdet ihr am Ende des Tages wissen?**

Was ist qualitative Forschung

The term qualitative research is used to describe a set of approaches that analyze data in the form of natural language (i.e., words) and expressions of experiences (e.g., social interactions and artistic presentations).



“understanding more fully”

The mechanism of storymaking: A Grounded Theory study of the 6-Part Story Method[☆]

Kim Dent-Brown^{a,*}, Michael Wang^b

^a *Leeds and Humber Mental Health Teaching NHS Trust, UK*
^b *Leeds and Humber Mental Health Teaching NHS Trust, UK*

PSYCHOSIS

<https://doi.org/10.1080/17522439.2022.2141843>

Abstract

Forty-nine participants (24 d instructions to create and tell a own life situation, and for their using Grounded Theory metho The majority of participants d This was accompanied by an participants this close identif

'Client's perspectives and the efficacy of drama therapy in psychosis'

Lauren A. Bradley^{1D}, Louise Combes^{1D}, Alex Perry^{1D} and Remennie Brodie^{1D}

Aspire (Early Intervention in Psychosis), Community Links, Leeds, West Yorkshire, UK

JASON S. FRY
Fordham Uni

JEREMY SEGAL
NYC Health

Investigating the glass escalator effect among registered drama therapists: A gender-based examination of professional trajectory

ABSTRACT

This research sought to identify whether the glass escalator was occurring on the profession of drama therapy. A survey asking drama therapists to complete a questionnaire was distributed to drama therapists across the UK. The results showed that the glass escalator was occurring on the profession of drama therapy. The results showed that the glass escalator was occurring on the profession of drama therapy. The results showed that the glass escalator was occurring on the profession of drama therapy.



Article

Qualitative and Arts-Based Evidence from Children Participating in a Pilot Randomised Controlled Study of School-Based Arts Therapies[†]

Zoe Mould^{1,*}^{1D}, Joanne Powell² and Vicky Karkou²



Research into the core processes of drama therapy: Vignettes and conversations

Phil Jones, PhD^{*}

Leeds Metropolitan University, Carnegie Faculty, Headingley Campus, Leeds LS6, United Kingdom

Therapist perceived active ingredients of school-based dramatherapy for children and young people with emotional distress

Eleanor Keiller^{a,*}¹, Taryn Hutchinson^{b,2}, Dennis Ougrin^{c,3}, Catherine Elizabeth Carr^{d,4}, Jennifer Y.F. Lau^{a,5}

^a Youth Resilience Unit, Centre for Psychiatry and Mental Health, Wolfson Institute of Population Health, Queen Mary University of London, UK
^b Department of Psychology, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, UK
^c Youth Resilience Unit, Centre for Psychiatry and Mental Health, Wolfson Institute of Population Health, Queen Mary University of London and East London NHS Foundation Trust, UK
^d Unit for Social and Community Psychiatry, Centre for Psychiatry and Mental Health, Wolfson Institute of Population Health, Queen Mary University of London and East London NHS Foundation Trust, UK
^e London NHS Foundation Trust, UK

ARTICLE INFO

Keywords:
Dramatherapy
Drama therapy
Psychotherapy
Therapeutic factors
Therapeutic processes
Active ingredients

ABSTRACT

Dramatherapy, a creative form of psychotherapy, is used as a treatment for children and young people (CYPs) who have common mental disorders including anxiety, depression and trauma. Although widely used, particularly in schools, little is known about the active ingredients of this intervention. A qualitative approach, triangulating both semi-structured interviews (N = 11) and a focus group (N = 5), was taken to elicit dramatherapists' perspectives on the active ingredients of school-based dramatherapy. 11 active ingredients were identified. That CYPs experience and express emotions (3) in dramatherapy, were found; dramatherapy's person-centredness (4) and the use of structure (5) were also found. The creation of safety, in the therapeutic relationship (6) and space ingredients, as were, dramatherapists' use of theory (9), the importance of a systemic approach (10) and that active ingredients of school-based dramatherapy for CYPs with emotional distress. The findings presented may inform further research, measuring mediators of change, and practice, which enhances symptom reduction.

Introduction

pers of children
and care



drama therapists' use of the concept of "core processes" (London, England: Routledge) to analyse change in narrative approaches to in-depth analysis. The study involved the use of the Internet through aMSN processes used to analyse vignettes and the use of each of these elements within a context. The study identifies the use of vignettes and

Qualitative Forschung - Design

Ziel und Forschungsfrage

- Fokus auf Bedeutung, Erfahrung, oder Prozess
- Abgrenzung des Untersuchungsrahmens
- Offen formulierte Forschungsfrage

Stichprobenauswahl

- Die Forschungsfrage bestimmt die Stichprobe
 - Einschluss- und Ausschlusskriterien
- Qualitative Forschung braucht eine detaillierte Beschreibung der Stichprobe



WHO ME!?
I THOUGHT YOU'D
NEVER ASK.

Wie viele Interviews sind genug?

"You keep asking as long as you are getting different answers"

Wolcott, 2004

- Data saturation
- Tiefe und Informationsgehalt des Interviews
- Orientierung an ähnlichen Studien
- Praktische Kompromisse

Datenerhebung

- Interviews
- Fokusgruppen
- Zeichnungen/Fotos
- Obserationen
- Fallstudien/Fallnotizen
- Tagebuch



Reflexivität

- Forschende sind *aktiver* Teil des Forschungsprozesses
- Eigene Position, Erfahrungen und Annahmen wirken mit
- Bewusster Umgang mit Nähe und Distanz
- Transparente Dokumentation reflexiver Entscheidungen



Ethische Aspekte

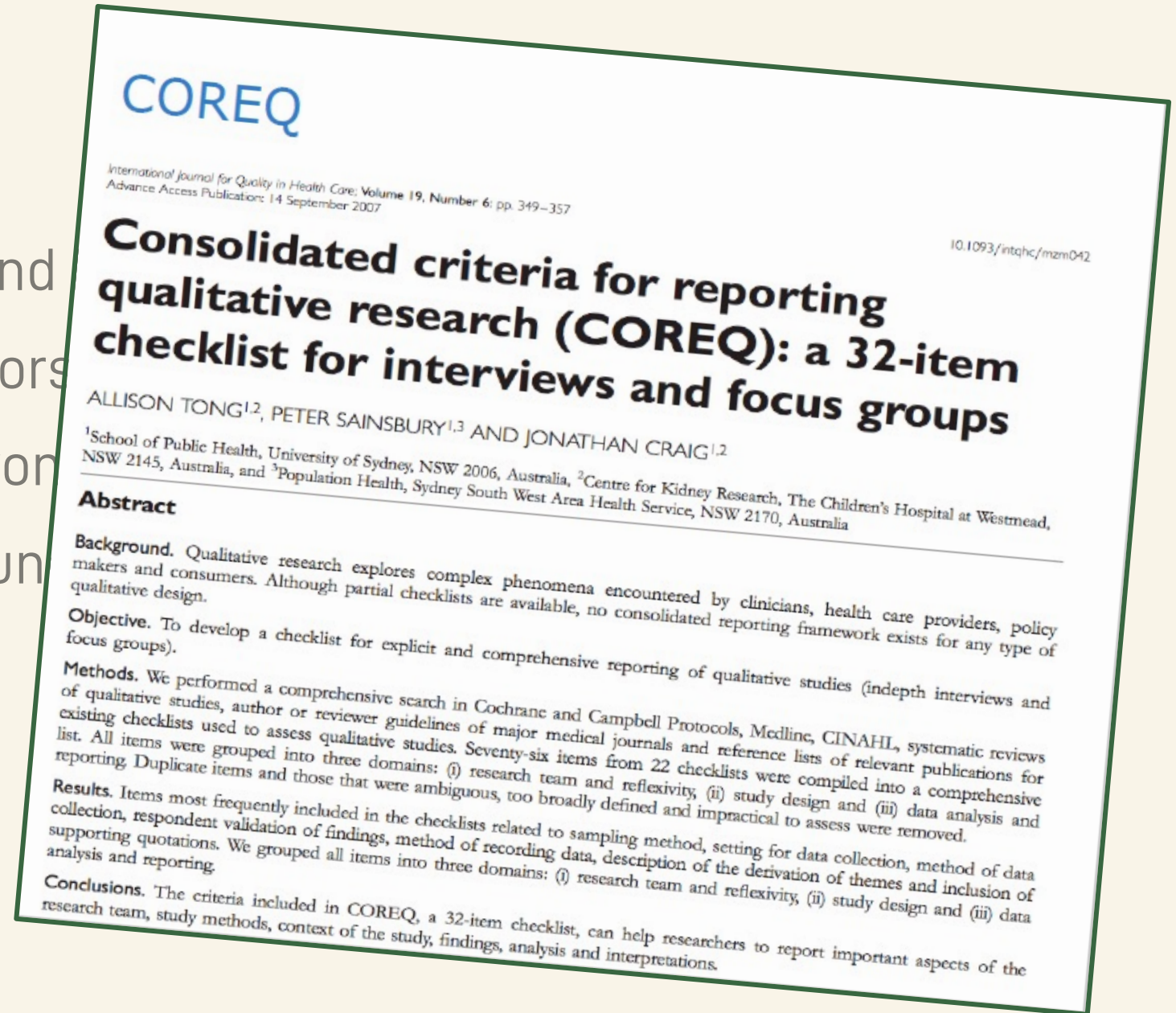
- **Informierte Einwilligung**
- Freiwilligkeit und Rücktrittsrecht
- Vertraulichkeit und **Anonymisierung**
- Sensibler Umgang mit persönlichen Inhalten
- Ethik als fortlaufender Prozess

Gütekriterien

- Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse
- Transparenz des Forschungsprozesses
- Angemessenheit von Design und Methoden
- Kontextualisierte und dichte Beschreibung

Gütekriterien

- Glaubwürdigkeit und
- Transparenz des Fors
- Angemessenheit von
- Kontextualisierte un



Lesegruppe I

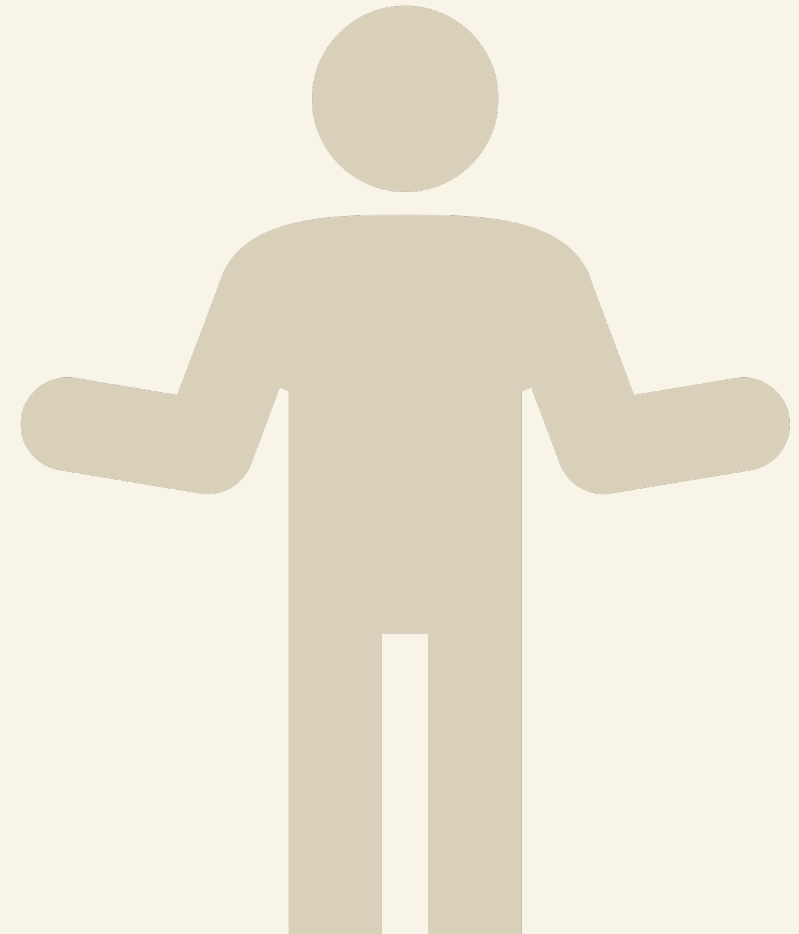
Yasmin Habaal & Tobias Constien, 2024

Facilitators and Barriers



Beschreibt die folgenden Aspekte:

- A** Studienteilnehmende
- B** Datenerhebung
- C** Reflexivität



Lesegruppe I

Yasmin Habaal & Tobias Constien, 2024

Facilitators and Barriers



Bewertet die Studie anhand der COREQ Kriterien

- *Domain 1 und Domain 2*



<i>Personal characteristics</i>		
Interviewer/facilitator	1	Which author/s conducted the interview or focus group?
Credentials	2	What were the researcher's credentials? E.g. PhD, MD
Occupation	3	What was their occupation at the time of the study?
Gender	4	Was the researcher male or female?
Experience and training	5	What experience or training did the researcher have?
<i>Relationship with participants</i>		
Relationship established	6	Was a relationship established prior to study commencement?
Participant knowledge of the interviewer	7	What did the participants know about the researcher? e.g. personal goals, reasons for doing the research
Interviewer characteristics	8	What characteristics were reported about the interviewer/facilitator? e.g. Bias, assumptions, reasons and interests in the research topic
Domain 2: Study design		
<i>Theoretical framework</i>		
Methodological orientation and Theory	9	What methodological orientation was stated to underpin the study? e.g. grounded theory, discourse analysis, ethnography, phenomenology, content analysis
<i>Participant selection</i>		
Sampling	10	How were participants selected? e.g. purposive, convenience, consecutive, snowball
Method of approach	11	How were participants approached? e.g. face-to-face, telephone, mail, email

Sample size	12	How many participants were in the study?
Non-participation	13	How many people refused to participate or dropped out? Reasons?
<i>Setting</i>		
Setting of data collection	14	Where was the data collected? e.g. home, clinic, workplace
Presence of non-participants	15	Was anyone else present besides the participants and researchers?
Description of sample	16	What are the important characteristics of the sample? e.g. demographic data, date
<i>Data collection</i>		
Interview guide	17	Were questions, prompts, guides provided by the authors? Was it pilot tested?
Repeat interviews	18	Were repeat inter views carried out? If yes, how many?
Audio/visual recording	19	Did the research use audio or visual recording to collect the data?
Field notes	20	Were field notes made during and/or after the inter view or focus group?
Duration	21	What was the duration of the inter views or focus group?
Data saturation	22	Was data saturation discussed?
Transcripts returned	23	Were transcripts returned to participants for comment and/or

Qualitative Analyse

"A key aspect of qualitative research is that **analysis is guided less by the expectations** of the researcher in advance of the analysis and **more by their reaction to and engagement** with the data during the analysis phase"

Guerin, 2013, p. 158

Qualitative Analyse

Quasi-Statistischer Ansatz

Untersucht Daten nach spezifischen Wörtern oder Sätzen, Häufigkeitsanalysen, stark strukturiert.

Blaupausen Ansatz

Kategoriensystem vor oder unmittelbar nach Beginn der Analyse ausgewählt, deduktive Ansatz.

Interpretativer Ansatz

Interpretationen in der Analyse bestimmt Kategorien, induktiver Ansatz.

Immersion Ansatz

Hohes Level an Interpretation, Forschende aktiv im Prozess eingebunden, kein strukturierter Vorgang.

Qualitative Analyse



Anna, 16 Jahre:

Ich kam zur Theatertherapie, weil ich mich in sozialen Kontexten oft unsicher gefühlt habe. Ich hab mich auch in den ersten Sitzungen von den anderen in der Gruppe nicht gesehen gefühlt. Ich hatte große Probleme mit der Szenenarbeit, und hab oft nur kleine, zurückhaltende Rollen gespielt. Das hat mir auch Sicherheit zunächst gegeben. Heute musste ich eine der Hauptrollen spielen – das war ungewohnt, aber irgendwie auch befreiend. Ich wurde gesehen.

Qualitative Analyse

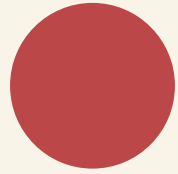


Quasi-Statistischer Ansatz

- Zählen vordefinierter Schlüsselbegriffe und Formulierungen
- Fokus auf was gesagt wird, nicht auf Bedeutungszusammenhänge

Negative Veränderungsbegriffe

Positive Veränderungsbegriffe



Quasi-Statistische Analyse



Anna, 16 Jahre:

Ich kam zur Theatertherapie, weil ich mich in sozialen Kontexten oft unsicher gefühlt habe. Ich hab mich auch in den ersten Sitzungen von den anderen in der Gruppe nicht gesehen gefühlt. Ich hatte große Probleme mit der Szenenarbeit, und hab oft nur kleine, zurückhaltende Rollen gespielt. Das hat mir auch Sicherheit zunächst gegeben. Heute musste ich eine der Hauptrollen spielen – das war ungewohnt, aber irgendwie auch befreiend. Ich wurde gesehen.

Quasi-Statistische Analyse



Anna, 16 Jahre:

*Ich kam zur Theatertherapie, weil ich mich in sozialen Kontexten oft unsicher gefühlt habe. Ich hab mich auch in den ersten Sitzungen von den anderen in der Gruppe **nicht gesehen gefühlt**. Ich hatte große Probleme mit der Szenenarbeit, und hab oft **nur kleine, zurückhaltende Rollen** gespielt. Das hat mir auch **Sicherheit zunächst gegeben**. Heute musste ich eine der Hauptrollen spielen – **das war ungewohnt**, aber **irendwie auch befreiend**. Ich **wurde gesehen**.*

Qualitative Analyse



Quasi-Statistischer Ansatz

- Zählen vordefinierter Schlüsselbegriffe und Formulierungen
- Fokus auf was gesagt wird, nicht auf Bedeutungszusammenhänge

Negative Veränderungsbegriffe: 3

nicht gesehen, zurückhaltend, ungewohnt

Positive Veränderungsbegriffe: 3

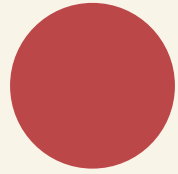
Sicherheit gegeben, befreiend, gesehen

Qualitative Analyse



Blaupausen Ansatz

- Daten werden in vorbereitete (theoretische) Kategorien sortiert.
 - Selbstwahrnehmung
 - Körperbewusstsein



Blaupausen Analyse



Anna, 16 Jahre:

Ich kam zur Theatertherapie, weil ich mich in sozialen Kontexten oft unsicher gefühlt habe. Ich hab mich auch in den ersten Sitzungen von den anderen in der Gruppe nicht gesehen gefühlt. Ich hatte große Probleme mit der Szenenarbeit, und hab oft nur kleine, zurückhaltende Rollen gespielt. Das hat mir auch Sicherheit zunächst gegeben. Heute musste ich eine der Hauptrollen spielen – das war ungewohnt, aber irgendwie auch befreiend. Ich wurde gesehen.

Blaupausen Ansatz



Anna, 16 Jahre:

*Ich kam zur Theatertherapie, weil ich mich in sozialen Kontexten oft unsicher gefühlt habe. Ich hab mich auch in den ersten Sitzungen von den anderen **in der Gruppe nicht gesehen gefühlt**. Ich hatte **große Probleme mit der Szenenarbeit**, und hab oft nur kleine, zurückhaltende Rollen gespielt. Das hat mir auch **Sicherheit zunächst gegeben**. Heute musste ich eine der Hauptrollen spielen – das war **ungewohnt, aber irgendwie auch befreiend**. Ich wurde gesehen.*

Qualitative Analyse



Blaupausen Ansatz

- Daten werden in vorbereitete (theoretische) Kategorien sortiert.

- **Selbstwahrnehmung**

Bewegung von Unsicherheit hin zu langsamer Sicherheit im eigenen Selbst.

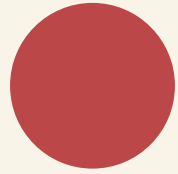
- **Körperbewusstsein**

Qualitative Analyse



Interpretativer Ansatz

- Offenes Lesen
- Bedeutungsverdichtung
- Kategorienbildung im Prozess



Interpretative Analyse



Anna, 16 Jahre:

Ich kam zur Theatertherapie, weil ich mich in sozialen Kontexten oft unsicher gefühlt habe. Ich hab mich auch in den ersten Sitzungen von den anderen in der Gruppe nicht gesehen gefühlt. Ich hatte große Probleme mit der Szenenarbeit, und hab oft nur kleine, zurückhaltende Rollen gespielt. Das hat mir auch Sicherheit zunächst gegeben. Heute musste ich eine der Hauptrollen spielen – das war ungewohnt, aber irgendwie auch befreiend. Ich wurde gesehen.

Interpretative Analyse



Interpretativer Ansatz

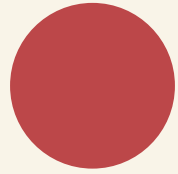
- Offenes Lesen
 - Bedeutungsverdichtung
 - Kategorienbildung im Prozess
-
- **Selbstschutz durch Rückzug**
 - **In ungewohnten Erfahrungen kann man sich neu erleben**

Qualitative Analyse



Immersion Ansatz

- Wiederholtes, intensives Eintauchen in den Text
- Einbezug eigener Wahrnehmungen und Resonanzen



Immersion Analyse



Anna, 16 Jahre:

[schnell] Ich kam zur Theatertherapie, weil ich mich in sozialen Kontexten oft unsicher gefühlt habe. Ich hab mich auch in den ersten Sitzungen von den anderen in der Gruppe nicht gesehen gefühlt [Schulterzucken]. Ich hatte [Betonung auf Vergangenheit] große Probleme mit der Szenenarbeit, und hab oft "nur" [deutet Anführungsstriche an] kleine, zurückhaltende Rollen gespielt. Das hat mir auch Sicherheit zunächst gegeben. Heute musste ich eine der Hauptrollen spielen – das war ungewohnt, aber irgendwie auch befreiend [lächelt, pause]. Ich wurde gesehen.

Qualitative Analyse



Interpretativer Ansatz

- Wiederholtes, intensives Eintauchen in den Text
- Einbezug eigener Wahrnehmungen und Resonanzen

Der Moment in dem Anna eine größere Rolle – zugegebenermaßen gezwungen – angenommen und gespielt hat war bedeutend für sie. Alte Erfahrungen haben an Bedeutung verloren. In der Rolle konnte Anna Anteile von sich erlebt, die befreit von sozialen Unsicherheiten sind.

Qualitative Analyse

Quasi-Statistischer Ansatz

Content and Frequency Analysis

Blaupausen Ansatz

Framework Analysis

Interpretativer Ansatz

Thematic Analysis, Grounded Theory

Immersion Ansatz

Interpretative Phenomenological Analysis,
Discourse Analysis

Qualitative Analyse

Ein deskriptiv-interpretativer Ansatz

- Qualitative Ansätze existieren unter vielen „**Markennamen**“, die sich aber mehr gleichen als wirklich unterscheiden.
- Forschende sollen Methoden flexibel kombinieren, passend zu:
 - Forschungsthema
 - Persönlichen Präferenzen
 - Stil der Datenerhebung und -analyse



Qualitative Analyse

Ein deskriptiv-interpretativer Ansatz

1. Daten Aufbereitung

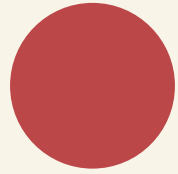
- Daten: Feldnotizen & Tonaufnahmen
- Tonaufnahmen werden wortgetreu transkribiert.
- Gesamtsichtung des Datensatzes um einen ersten Überblick gewinnen
- Erste Einsichten als Memos festhalten
- Erste Bereinigung: Redundanzen & Irrelevantes entfernen

Qualitative Analyse

Ein deskriptiv-interpretativer Ansatz

2. Daten Abgrenzen

- Daten werden in Bedeutungseinheiten (Meaning Units) unterteilt
 - Eine kurze Einheit, die in sich selber, ohne Kontext verständlich ist.
- Meaning Units = zentrale Analyseeinheiten
- Jede Einheit erhält einen eindeutigen numerischen Code zur Rückverfolgbarkeit

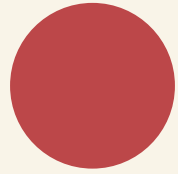


Bedeutungseinheiten finden:



Anna, 16 Jahre:

Ich kam zur Theatertherapie, weil ich mich in sozialen Kontexten oft unsicher gefühlt habe. Ich hab mich auch in den ersten Sitzungen von den anderen in der Gruppe nicht gesehen gefühlt. Ich hatte große Probleme mit der Szenenarbeit, und hab oft nur kleine, zurückhaltende Rollen gespielt. Das hat mir auch Sicherheit zunächst gegeben. Heute musste ich eine der Hauptrollen spielen – das war ungewohnt, aber irgendwie auch befreiend. Ich wurde gesehen.



Bedeutungseinheiten finden:



Anna, 16 Jahre:

~~Ich kam zur Theatertherapie, weil ich mich in sozialen Kontexten oft unsicher gefühlt habe.~~ Ich hab mich auch in den ersten Sitzungen von den anderen in der Gruppe nicht gesehen gefühlt. Ich hatte große Probleme mit der Szenenarbeit, und hab oft nur kleine, zurückhaltende Rollen gespielt. Das hat mir auch Sicherheit zunächst gegeben. Heute musste ich eine der Hauptrollen spielen – das war ungewohnt, aber irgendwie auch befreiend. Ich wurde gesehen.

Qualitative Analyse

Ein deskriptiv-interpretativer Ansatz

4. Dialog mit den Daten – interpretative Kategorienbildung

- Meaning Units werden innerhalb der Domains in Kategorien gefasst
- Kategorien entstehen aus Ähnlichkeiten und Regelmäßigkeiten im Material
 - **Interpretativer Prozess:**
 - nah an der Sprache der Teilnehmenden
 - informiert durch theoretisches Vorwissen
- Labels werden im Analyseprozess verfeinert
- Meaning Units ggf. neu zugeordnet
- ständiger Vergleich zwischen Daten & Kategorien

Qualitative Analyse

Ein deskriptiv-interpretativer Ansatz

5. Abstraktion

- Kategoriensystem oft zu komplex und brauchen weitere Abstraktion
- Prinzip der **essenziellen Suffizienz**:
 - so einfach wie möglich
 - so umfassend wie nötig
- *Welche Kategorien sind notwendig, um die Essenz des Phänomens zu vermitteln?*
- Narrative, Diagramme, Modelle, Tabellen

Qualitative Analyse

Ein deskriptiv-interpretativer Ansatz

6. Validität

- Erwartungscheck
- Kritisches, unabhängiges Auditing
 - intern während der Analyse
 - zentraler Audit nach Fertigstellung der Gesamtanalyse
- Rückmeldung der Teilnehmenden (Member Checking)
- Triangulation verschiedener Methoden / Datenquellen
- Dichte Beispiele & Zitate



Systematic Literature Review

20 Studies selected from 313 initial search results



313 initial search results

- Title & Abstract Screening
- Full-Text Screening
- Post-Search Alerts

20 included Studies

- Qualitative studies
- Clients
- Drama therapy

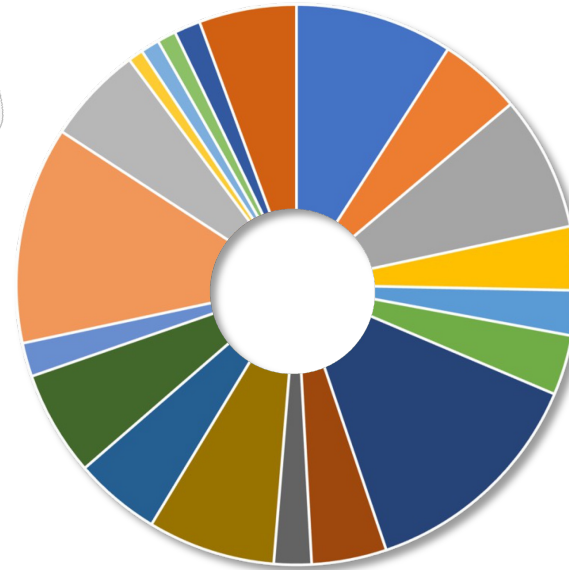


Analysis

460 Meaning Units extracted from 20 Studies



20 studies



460 Meaning Units

- The smallest piece of text that can still convey a meaning on its own.



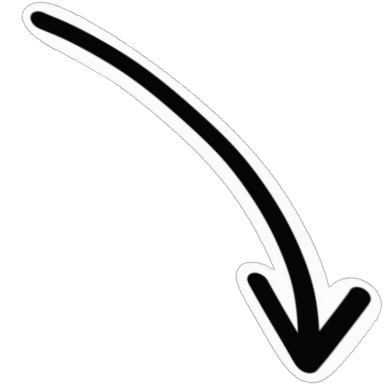
Analysis

A meaning unit refers to the smallest bit of text that still conveys a meaning.

Theme 1: Playing as a means of self-expression. The interviewees reported a positive affect directly related to the dramatic acting itself as a form of self-expression that involves a sense of pleasure, release, creativity, and humor and, for most of them, it was a first-time experience, as shared by Mary (an 84-years-old woman):

“How I love, I love (to play). I felt good. And I had never acted before, maybe once. . .when I was in the fourth grade. . . I think we performed Cinderella.”

Keisari et al., 2020, p. 12



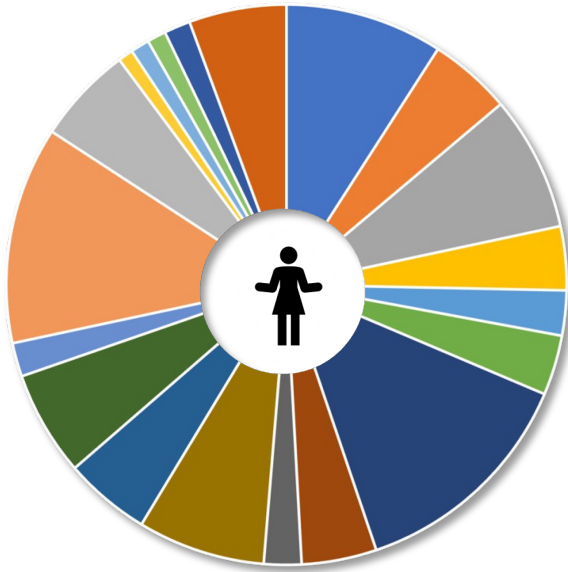
Category: Playing as a means of self-expression

Description: The interviewees reported a positive affect directly related to the dramatic acting itself...

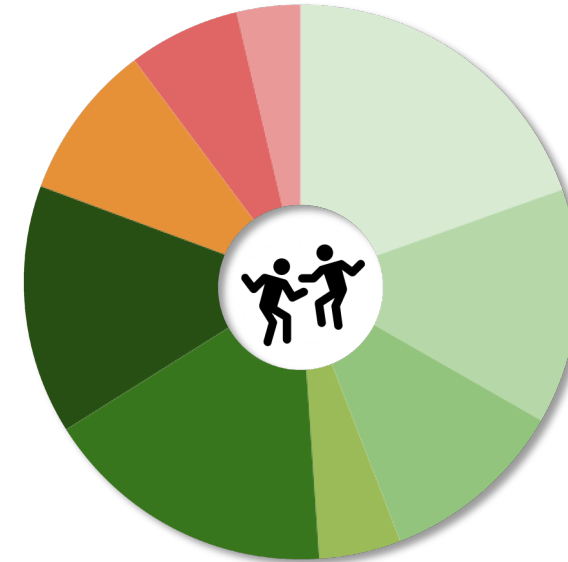
Quote: “How I love, I love (to play)...”

Analysis

460 Meaning Units from 20 Studies sorted into 9 Meta-Categories



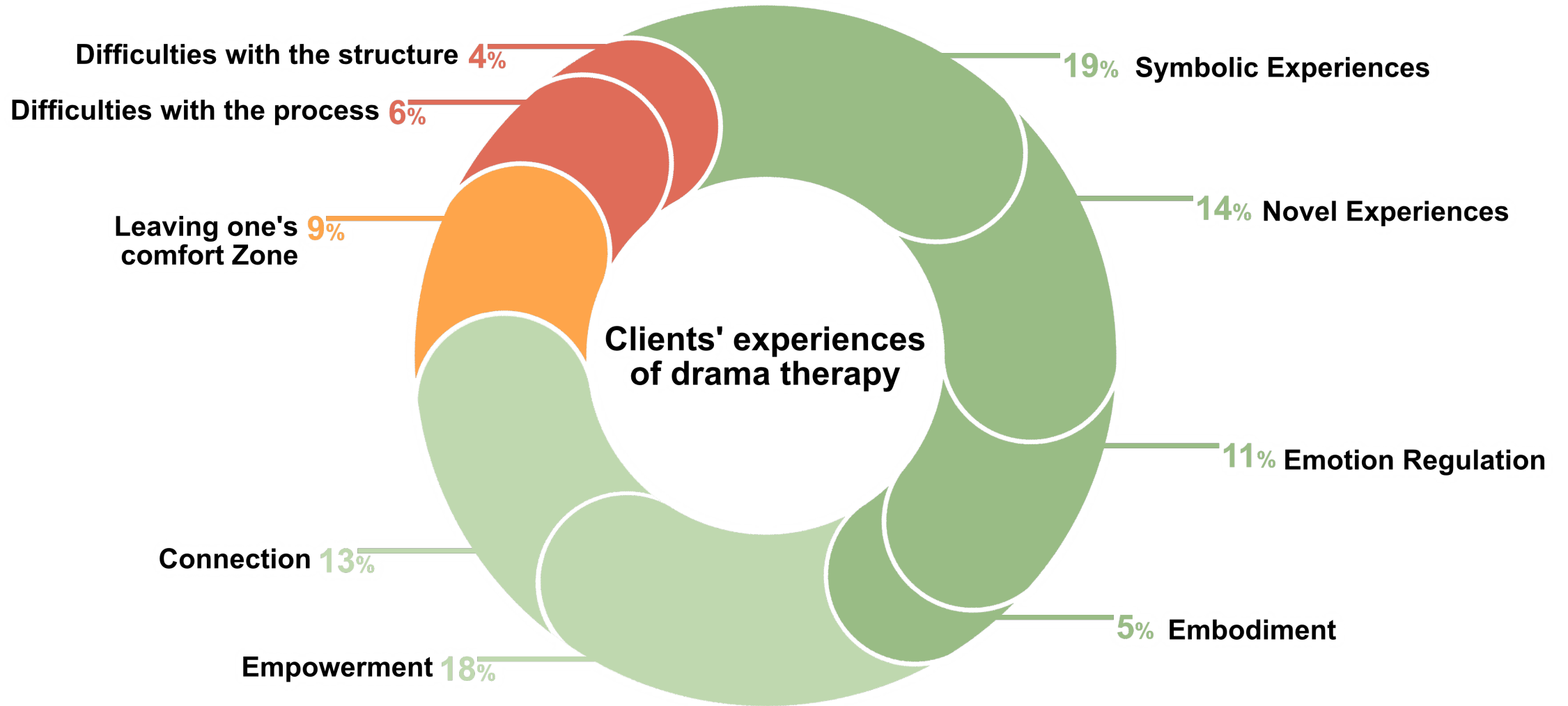
**460 Meaning Units extracted
from 20 studies**



9 Categories sorted into three Domains

- Supportive Aspects of Drama Therapy
- Supportive but Difficult Aspects of Drama Therapy
- Obstructive Aspects of Drama Therapy

RESULTS



N (Meaning Units) = 460

Lesegruppe I

Constien, Khanna & Wiberg, 2024

Client Experiences of Dramatherapy



Führt eure eigene Analyse durch!

A

Domain 1: Projektion

B

Domain 2: Gemeinschaft

C

Domain 3: Regulation

